O‘zbekiston Respublikasi
Sog‘liqni saqlash vazirligining
2025 yil “____”_____dagi
“_____”-sonli buyrug‘iga
___-ILOVA

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG`LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN KARDIOLOGIYA ILMIY-AMALIY TIBBIYOT MARKAZI

“MIOKARDIT” NOZOLOGIYA BO‘YICHA TIBBIY XIZMAT KO’RSATISH MILLIY KLINIK STANDARTLARI

TOSHKENT – 2025

"TASDIQLAYMAN"
O`zbekiston Respublikasi sog`liqni
saqlash vaziri
A.A. Xudayarov
_____
«____»_____2025 y .

“MIOKARDIT” NOZOLOGIYA BO‘YICHA TIBBIY XIZMAT KO’RSATISH MILLIY KLINIK STANDARTLARI

TOSHKENT – 2025



«KELISHILGAN»
RIKIATM direktori
X.G‘. Fozilov
_____
"____" _____ 2025 yil

“MIOKARDIT” NOZOLOGIYA BO‘YICHA TIBBIY XIZMAT KO’RSATISH MILLIY KLINIK STANDARTLARI

TOSHKENT 2025

MIOKARDIT

NOZOLOGIYASI BO‘YICHA TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH MILLIY KLINIK STANDARTI

XKT-10 bo’yicha kodlanishi:	Nozologik nomlanishi:	Nozologiya bo‘yicha ambulatoriya sharoitida tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar		Nozologiya bo‘yicha statsionar sharoitda tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar	
		Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo‘shimcha jalb etiladigan mutaxassislar	Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo‘shimcha jalb etiladigan mutaxassislar
I40	O‘tkir miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
I40.0	Infeksion miokardit Septik miokardit Infeksion agent identifikasiyasi zaruriyati bo‘lganda qo‘shimcha kod qo‘llaniladi (B95-B97)	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
I40.1	Izolirlangan miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
I40.8	O‘tkir miokarditni boshqa turlari	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
I40.9	O‘tkir miokardit aniqlashtirilmagan	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR

I41	Boshqa ruknlarda tasniflangan kasalliklardagi miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
I41.0	Boshqa ruknlarda tasniflangan bakterial kasalliklardagi miokardit: Difteriyli (A36.8) Gonokokkli (A54.8) Meningokokkli (A39.5) Sifilitik (A52.0) Tuberkulyoz (A18.8)	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR, dermatovenerolog
I41.1	Boshqa ruknlarda tasniflangan virusli kasalliklardagi miokardit: Grippli (o‘tkir) miokardit: virus identifikasiyalangan (J10.8), virus identifikasiyalanmagan (J11.8) Parotitli miokardit (B26.8)	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
I41.2	Boshqa ruknlarda tasniflangan infeksion va parazitar kasalliklardagi miokardit: Shagas kasalligidagi o‘tkir (B57.0) yoki surunkali (B57.2) miokardit Toksoplazmozli miokardit (B58.8)	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
I41.8	Boshqa ruknlarda tasniflangan boshqa kasalliklardagi miokardit: Revmatiodli miokardit (M05.3) Sarkoidli miokardit (D86.8)	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR

I51.4	Miokardit aniqlashtirilmagan Miokard fibrozi Surunkali miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR

XKT-11 bo'yicha kodlanishi:	**Nozologik nomlanishi:**	**Nozologiya bo'yicha ambulatoriya sharoitida tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar**		**Nozologiya bo'yicha statsionar sharoitda tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar**	
		Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo'shimcha jalb etiladigan mutaxassislar	Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo'shimcha jalb etiladigan mutaxassislar
BC42.Z	Miokardit, boshqa ruknda tasniflanmagan	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
BC42.1	Infeksion miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
BC42.1&XN3BH	Virusli miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
BC42.1&XN74M	Bakterial miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
BC42.3	Revmatik miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist,	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh,

			Endokrinolog, pulmonolog, LOR		endokrinolog, pul'monolog, LOR
BC42.Y	Boshqa aniqlangan miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
BC42.1&XN8AY	Zamburug‘li miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR, dermatovenerolog
1A62.1/BC42.1	Zaxm miokarditi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
BC42.1&XN9S1	Parazitar miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
1A72.Y/BC42.1	Gonokokkli miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
BC42.2	Eozinofilli miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
BC42.0	Gigant hujayrali miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh,

					endokrinolog, pul'monolog, LOR
1C1C.Y/BC42.1	Meningokokkli miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
4B20.Y	Sarkoid miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
1C17.Y/BC42.1	Difteriyali miokarditi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
BC42.1&XN0WC	Aspergillyoz miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
BC42.1&XT8W&XN74M	Surunkali bakterial miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
BC42.1&XT5R&XN74M	O‘tkir bakterial miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
1D80.Y/BC42.1	Parotit miokarditi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR

1F57.Y/BC42.1	Toksoplazmozli miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
1A07.Y/BC42.1	Qorin tifidagi miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
BC42.1&XN4YH	Rikketsioz miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
1B41.2	O‘tkir revmatik miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
1D85.4	Koksaki virusli miokarditi	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
1B12.0/BC42.1	Tuberkulyozli miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
1F53.2/BC42.1	Chagas kasalligi oqibatidagi miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
1E32/BC42.1	Grippda miokardit, virus aniqlanmagan	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist,	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr,

			Endokrinolog, pulmonolog, LOR		kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR
1E30/BC42.1	Boshqa aniqlangan gripp virusi miokardit	UASh/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, Endokrinolog, pulmonolog, LOR	Kardiolog/Intervension aritmolog/reanimatolog	Revmatolog, Infeksionist, Ftiziatr, kardiojarroh, endokrinolog, pul'monolog, LOR

***standartni to‘ldirish jarayonida nozologiya, uning kattalar, xomiladorlar, bolalar va qariyalarda kechuvi hamda nozologiya bo‘yicha kasallikni davri xususiyatidan kelib chiqish talab etiladi.**

Shuningdek, nozologiya ga to‘g‘ri kelmaydigan jadvallarni to‘ldirish tavsiya qilinmaydi. (Misol uchun, jarroxlik amaliyoti nozologiyasida o‘tkazilmasa (JARROHLIK AMALIYOTI) jadvali to‘ldirilmaydi yoki nozologiyada palliativ davo ko‘zda tutilmasa – (PALLIATIV DAVO) jadvali to‘ldirilmaydi.

DIAGNOSTIKA, DAVOLASH, REABILITATSIYA va DISPANSERIZATSIYA TADBIRLARI

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha					Xizmat ko‘rsatish yoki tekshiruvni o‘tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
		OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Asosiy mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Oilaviy shifokor	+					O‘tkir asoratlanmagan miokarditdan keyin oyiga bir marta 3 oy davomida	Ambulator kuzatuv o‘tkir miokarditda 3 oy, surunkali miokarditda SYuE bilan bo‘lsa - umrbod; Stasionar davolanish: 10-12 kun*
	2. Kardiolog		+	+	+	+	- o‘tkir asoratlanmagan miokarditdan keyin 1 marta - 3 oy davomida har oyda bir marta o‘tkir asoratlangan miokarditdan keyin - SYuYe I-II FS bilan surunkali miokardit uchun: yiliga 2 marta; - SYuYe III-IV FS bilan surunkali miokardit uchun yiliga 4 marta	
	3. Terapevt		+	+				
Izoh: * statsionar sharoitidagi davolanish muddati bo‘lgan gospitalizatsiya maqsadiga bog‘liq. Statsionar sharoitidagi mutaxassis ko‘riklari har kungi bo‘ladi.								
Mutaxassis (shifokor)	1. Intervension aritmolog			+	+	+	Ko‘rsatmaga binoan	

maslahati (qo‘shimcha)	2. Kardiojarroh				+	+		
	3. Revmatolog		+	+	+	+		
	4. Infeksionist		+	+	+	+		
	5. Ftiziatr			+	+	+		
Izoh: Barcha tor mutaxassislar ko‘rigi ko‘rsatmaga binoan tashkillashtiriladi. Statsionar sharoitada tor mutaxassislarning ko‘rik soni klinik holatiga muvofiq tashkillashtirilishi lozim.								
Asosiy laborator tekshiruvlar	1. Umumiy qon tahlili	+	+	+	+	+	- o‘tkir asoratlanmagan miokarditdan keyin 1 marta - 3 oy davomida har oyda bir marta o‘tkir asoratlangan miokarditdan keyin - SYuYe I-II FS bilan surunkali miokardit uchun: yiliga 2 marta; - SYuYe III-IV FS bilan surunkali miokardit uchun yiliga 4 marta	
	2. Umumiy siydik tahlili	+	+	+	+	+		
	3. Qondagi kreatinin	+	+	+	+	+		
	4. ALT, AST, bilirubin	+	+	+	+	+		
	5. Qondagi qand	+	+	+	+	+		
	6. C-reaktiv oqsil	+	+	+	+	+		
	7. ASLO		+	+	+	+		
	8. RF		+	+	+	+		
Izoh: agar OSHP/OP moddiy-texnik bazasi o‘tkir fazali sinamalarni (CRO, ASLO, RF) tekshirish imkoyanitiga ega bo‘lsa, oilaviy shifokor tomonidan bu tekshiruvlar bajarilishi lozim. Statsionar sharoitida laborator tekshiruvlarning soni klinik holatdan kelib chiqqan tarzda aniqlanadi.								
Qo‘shimcha laborator tekshiruvlar	1. Troponinlar		+	+	+	+	Ko‘rsatmaga binoan	
	2. MB-KFK			+	+	+		
	3. RW			+	+	+		
	4. Qon guruhi			+	+	+		
	5. Gepatit B va C			+	+	+		
	6. OIV			+	+	+		
	7. MNUP				+	+		
	8. TTG		+	+	+	+		

	9. Virus infeksiyani serologik markyorlari		+	+	+	+		
	10. Biologik suyuqliklarning bakterial ekmasi							
	11. Elektrolitlar		+	+	+	+		
	12. Umumiy oqsil		+	+	+	+		
	13. Albumin		+	+	+	+		
	14. D-dimer				+	+		
	15. Prokalsitonin				+	+		
	16. Koagulogramma		+	+	+	+		
	17. Kislota-ishqoriy muvozanatni baholash				+	+		
Izoh: Qon guruhi, gepatit B va C, OIV ga tekshiruvlar jarrohlik amaliyotlar rejalashtirilgan bemorlar uchun bajarilishi lozim. Statsionar sharoitida laborator tekshiruvlarning soni klinik holatdan kelib chiqqan tarzda aniqlanadi.								
Asosiy instrumental tekshiruvlar	1. EKG	+	+	+	+	+	- o‘tkir asoratlanmagan miokarditdan keyin 1 marta - 3 oy davomida har oyda bir marta o‘tkir asoratlangan miokarditdan keyin - SYuYe I-II FS bilan surunkali miokardit uchun: yiliga 2 marta; - SYuYe III-IV FS bilan surunkali miokardit uchun yiliga 4 marta	
Izoh: Statsionar sharoitida EKGni soni klinik holatdan kelib chiqqan tarzda aniqlanadi.								
Qo‘shimcha	1. ExoKG		+	+	+	+	Ko‘rsatmaga	

instrumental tekshiruvlar	2. Paramagnit kontrast bilan kuchaytirilgan yurak MRT tekshiruvi					+	binoan	
	3. Ko'krak qafasi rentgenografiyasi		+	+	+	+		
	4. Xolter bo'yicha EKG ni monitorlash				+	+		
	5. Invaziv koronarografiya				+	+		
	6. EFT				+	+		
	7. Ichki a'zolar UTT		+	+	+	+		
Izoh: Statsionar sharoitida instrumental tekshiruvlarning soni klinik holatdan kelib chiqqan tarzda aniqlanadi.								

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
		OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	1. CHA2DS2-VASc va HAS-BLED shkalalari	+	+	+	+	+	Har ko'rikda	
Izoh: Miokardit va bo'lmachalar fibrillyasiyasi bo'lgan bemorlar ishemik insul't xavfini baholash uchun CHA2DS2-VASc shkalasi qo'llaniladi. Miokardit va bo'lmachalar fibrillyasiyasi bo'lgan bemorlar oral antikoagulyantlar qo'llanilganda qon ketish ehtimolligini baholash uchun HAS-BLED shkalasi qo'llaniladi.								

(MEDIKAMENTOZ TERAPIYA)

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		REJALI tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
1. Viruslarga qarshi dori vositalar[1]:	- Interferon alfa-2b 100000-300000 TB			+	+	+	- Interferon al'fa-2b	Terapiya muddati

- Interferon alfa-2b - Immunoglobulin	sutkasiga m/o; - Immunoglobulin 1 ml bemor 1 kg vazniga nisbatan m/o 2-3 mahal						100000-300000 TB sutkasiga m/o; - Immunoglobulin 1 ml bemor 1 kg vazniga nisbatan m/o 2-3 mahal	klinik holatiga bog‘liq
2. Antibiotiklar[2]: A) Penisillinlar: - Amoksisillin B) Sefalosporinlar: - Seftriakson - Sefiksim C) Ftorxinolonlar: - Siprofloksasin - Levofloksasin	- Amoksisillin 1000 mg 1 tabl. 2 mahal; - Seftriakson 1,0 gr 2 mahal v/i ili m/o; - Sefiksim 400 mg 1 tabl. 1 mahal; - Siprofloksasin 500 mg 1 tabl. 2 mahal; - Levofloksasin 500-1000 mg 1 tabl. 1 mahal	+	+	+	+	+	- Amoksisillin 1000 mg 1 tabl. 2 mahal; - Seftriakson 1,0 gr 2 mahal v/i ili m/o; - Sefiksim 400 mg 1 tabl. 1 mahal; - Siprofloksasin 500 mg 1 tabl. 2 mahal; - Levofloksasin 500-1000 mg 1 tabl. 1 mahal	7-10 kun
3. Kolxisin[3]	Kolxisin 0,5-1 mg 1 tabl. 1 mahal		+	+	+	+	Kolxisin 0,5-1 mg 1 tabl. 1 mahal	3-6 oy
4. Glyukokortikosteroidlar[4]: - Prednizolon	Prednizolon 30-40 mg kuniga		+	+	+	+	Prednizolon 30-40 mg kuniga	3-6 oy
5. RAAT blokatorlari: A) AAF ingibitorlari: - Enalapril - Ramipril - Perindopril Б) ARB (sartanlar): - Valsartan - Lozartan - Kandesartan - Telmisartan - Azilsartan	AAFi: - Enalapril 2,5-20 mg kunlik dozasi 2 marta sutkasiga bo‘linib beriladi - Ramipril 2,5-10 mg 1 marta sutkasiga - Perindopril erbumin 2-8 mg 1 marta sutkasiga - Perindopil arginin	+	+	+	+	+	AAFi: - Enalapril 2,5-20 mg - Ramipril 2,5-10 mg - Perindopril erbumin 2-8 mg - Perindopil arginin 2,5-10 mg ARB: - Valsartan – 40-	Terapiya muddati klinik holatiga bog‘liq

- Olmesartan	**2,5-10 mg 1 marta sutkasiga ARB: - Valsartan – 40-320 mg kunlik dozasi 2 marta sutkasiga bo‘linib beriladi - Lozartan 25-100 mg 1 marta sutkasiga - Kandesartan 4-32 mg 1 marta sutkasiga - Telmisartan 10-80 mg 1 marta sutkasiga - Azilsartan 20-80 mg 1 marta sutkasiga - Olmesartan 10-40 mg 1 marta sutkasiga**						**320 mg - Lozartan 25-100 mg - Kandesartan 4-32 mg - Telmisartan 10-80 mg - Azilsartan 20-80 mg - Olmesartan 10-40 mg**	
6. ARNI[5]: - Sakubitril/Valsartan	**24/26 mg (50 mg), 49/51 mg (100 mg) yoki 97/103 mg (200 mg). 1 tabletkadan 2 mahal (QB nazorati dozasi aniqlanadi)**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**100-400 mg**	**Terapiya muddati klinik holatiga bog‘liq**
7. Beta-blokatorlar: - Bisoprolol - Metoprolol - Nebivalol - Karvedilol	**- Bisoprolol 2,5-10 mg 1 marta sutkasiga - Metoprolol suksinat 25-100 mg 1 marta sutkasiga - Nebivalol 2,5-10 mg 1 marta sutkasiga**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**- Bisoprolol 2,5-10 mg - Metoprolol suksinat 25-100 mg - Nebivalol 2,5-10 mg - Karvedilol 3,125-25 mg**	**Terapiya muddati klinik holatiga bog‘liq**

	- Karvedilol 3,125-25 mg kunlik dozasi 2-3 marta sutkasiga bo‘linib beriladi							
8. Mineralokortikoid reseptori antagonistlari: - Spironolakton - Eplerenon	- Spironolakton 25-50 mg 1 tabl. (kaps) 1 mahal; - Eplerenon 25-50 mg 1 tabl. 1 mahal	+	+	+	+	+	- Spironolakton 25-50 mg 1 tabl. (kaps) 1 mahal; - Eplerenon 25-50 mg 1 tabl. 1 mahal	Terapiya muddati klinik holatiga bog‘liq
9. SGLT2-ingibitorlari: - Empagliflozin - Dapagliflozin	- Empagliflozin 10-25 mg 1 tabl. 1 mahal; - Dapagliflozin 10 mg 1 tabl. 1 mahal.	+	+	+	+	+	- Empagliflozin 10-25 mg 1 tabl. 1 mahal; - Dapagliflozin 10 mg 1 tabl. 1 mahal.	Terapiya muddati klinik holatiga bog‘liq

Izoh: [1] Virusli miokarditga shubha bo‘lsa, virusga qarshi dori vositalari qo‘llanilishi mumkin.

[2] Antibiotiklarni faqat bakterial infeksiyasi tasdiqlangan taqdirda qo‘llash mumkin. Antibiotiklarga sezuvchanlik natijalariga ko‘ra, boshqa turidagi antibakterial vositalardan foydalanish mumkin.

[3] Kolxisinni miokardit yondosh perikardit bilan birga kechsa, qo‘llash tavsiya etiladi.

[4] Glyukokortikosteroidlar uchun ko‘rsatma: limfositar miokardit; gigant hujayrali miokardit; autoimmun kasalliklar bilan bog‘liq miokardit; sarkoidli miokardit; allergik miokardit.

[5] ARNI ChQ OF past (<40%) bo‘lgan miokarditli bemorlarda RAAT blokatorlariga qaraganda afzalroq.

Beta-blokatorlar, RAAT blokatorlari (AAFi yoki sartanlar), MKRA va SGLT2-ingibitorlari miokarditning nospesifik terapiyasi deb hisoblanadi va barcha bemorlarga buyurilishi mumkin.

Davolash tadbirlari (qo‘shimcha medikamentoz davo)		REJALI tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha					O‘rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo‘llanilishi	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
1. Oral antikoagulyantlar[1]: - Rivaroksaban - Apiksaban	- Rivaroksaban 15-20 mg 1 mahal - Apiksaban 2,5-5 mg 2 mahal		+	+	+	+	- Rivaroksaban 15-20 mg 1 mahal - Apiksaban 2,5-5 mg 2 mahal	Terapiya muddati klinik holatiga bog‘liq
2. Bevosita antikoagulyantlar: - Geparin	- Geparin 5000 TB t/o 4 mahal;			+	+	+	- Geparin 5000 TB t/o 4 mahal;	

- Enoksiparin	- Enoksiparin 100 antiXa TB bemorni 1 kg vazniga nisbatan 2 mahal						- Enoksiparin 100 antiXa TB bemorni 1 kg vazniga nisbatan 2 mahal	
3. Antiaritmiklar: - Amiodaron -Allapinin - Propafenon - Etasizin - Verapamil - Diltiazem	- Amiodaron 200 mg to‘yindirsh sxemasi bo‘yicha; - Allapinin 25 mg 1 tabl. mahal; - Propafenon 150 mg 1 tabl. 3 mahal; - Etasizin 50 mg 1 tabl. 3 mahal; - Verapamil 80-160 mg 1 tabal. 2-3 mahal; - Diltiazem 90 mg 1 tabl. 2 mahal		+	+	+	+	- Amiodaron 200 mg to‘yindirsh sxemasi bo‘yicha; - Allapinin 25 mg 1 tabl. mahal; - Propafenon 150 mg 1 tabl. 3 mahal; - Etasizin 50 mg 1 tabl. 3 mahal; - Verapamil 80-160 mg 1 tabal. 2-3 mahal; - Diltiazem 90 mg 1 tabl. 2 mahal	
4. Ivabradin	5-7,5 mg 1 tabl. 2 mahal		+	+	+	+	5-7,5 mg 1 tabl. 2 mahal	
5. Trimetazidin	80 mg 1 marta sutkasiga, 35 mg 2 marta sutkasiga	+	+	+	+	+	70-80 mg	
6. Ranolazin	500-1000 mg 2 marta sutkasiga	+	+	+	+	+	1000-2000 mg	
7. Halqa diuretiklar: - Furosemid - Torasemid	- Furosemid 40 mg 1 tabl. 1 mahal; - Torasemid 10 mg 1 tabl. 1 mahal	+	+	+	+	+	- Furosemid 40 mg 1 tabl. 1 mahal; - Torasemid 10 mg 1 tabl. 1 mahal	
Izoh: [1]Miokardit bilan og‘rigan bemorlarda BF borligida oral antikoagulyantlari buyuriladi.								

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		SHOSHILINCH tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha					O‘rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo‘llanilishi	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
1. Viruslarga qarshi dori vositalar[1]: - Interferon alfa-2b - Immunoglobulin	- Interferon alfa-2b 100000-300000 TB sutkasiga m/o; - Immunoglobulin 1 ml bemor 1 kg vazniga nisbatan m/o 2-3 mahal			+	+	+	- Interferon al'fa-2b 100000-300000 TB sutkasiga m/o; - Immunoglobulin 1 ml bemor 1 kg vazniga nisbatan m/o 2-3 mahal	Terapiya muddati klinik holatiga bog‘liq
2. Antibiotiklar[2]: A) Penisillinlar: - Amoksisillin B) Sefalosporinlar: - Seftriakson - Sefiksim C) Ftorxinolonlar: - Siprofloksasin - Levofloksasin	- Amoksisillin 1000 mg 1 tabl. 2 mahal; - Seftriakson 1,0 gr 2 mahal v/i ili m/o; - Sefiksim 400 mg 1 tabl. 1 mahal; - Siprofloksasin 500 mg 1 tabl. 2 mahal; - Levofloksasin 500-1000 mg 1 tabl. 1 mahal	+	+	+	+	+	- Amoksisillin 1000 mg 1 tabl. 2 mahal; - Seftriakson 1,0 gr 2 mahal v/i ili m/o; - Sefiksim 400 mg 1 tabl. 1 mahal; - Siprofloksasin 500 mg 1 tabl. 2 mahal; - Levofloksasin 500-1000 mg 1 tabl. 1 mahal	7-10 kun
3. Kolxisin[3]	Kolxisin 0,5-1 mg 1 tabl. 1 mahal		+	+	+	+	Kolxisin 0,5-1 mg 1 tabl. 1 mahal	3-6 oy
4. Glyukokortikosteroidlar[4]: - Prednizolon	Prednizolon 30-40 mg kuniga		+	+	+	+	Prednizolon 30-40 mg kuniga	3-6 oy
5. RAAT blokatorlari: A) AAF ingibitorlari: - Enalapril	AAFi: - Enalapril 2,5-20 mg kunlik dozasi 2	+	+	+	+	+	AAFi: - Enalapril 2,5-20 mg	Terapiya muddati klinik

- Ramipril - Perindopril Б) ARB (sartanlar): - Valsartan - Lozartan - Kandesartan - Telmisartan - Azilsartan - Olmesartan	marta sutkasiga bo‘linib beriladi - Ramipril 2,5-10 mg 1 marta sutkasiga - Perindopril erbumin 2-8 mg 1 marta sutkasiga - Perindopil arginin 2,5-10 mg 1 marta sutkasiga ARB: - Valsartan – 40-320 mg kunlik dozasi 2 marta sutkasiga bo‘linib beriladi - Lozartan 25-100 mg 1 marta sutkasiga - Kandesartan 4-32 mg 1 marta sutkasiga - Telmisartan 10-80 mg 1 marta sutkasiga - Azilsartan 20-80 mg 1 marta sutkasiga - Olmesartan 10-40 mg 1 marta sutkasiga						- Ramipril 2,5-10 mg - Perindopril erbumin 2-8 mg - Perindopil arginin 2,5-10 mg ARB: - Valsartan – 40-320 mg - Lozartan 25-100 mg - Kandesartan 4-32 mg - Telmisartan 10-80 mg - Azilsartan 20-80 mg - Olmesartan 10-40 mg	holatiga bog‘liq
6. ARNI[5]: - Sakubitril/Valsartan	24/26 mg (50 mg), 49/51 mg (100 mg) yoki 97/103 mg (200 mg). 1 tabletkadan 2 mahal (QB nazorati dozasi aniqlanadi)	+	+	+	+	+	100-400 mg	Terapiya muddati klinik holatiga bog‘liq
7. Beta-blokatorlar:	- Bisoprolol 2,5-10	+	+	+	+	+	- Bisoprolol 2,5-	Terapiya

- Bisoprolol - Metoprolol - Nebivalol - Karvedilol	mg 1 marta sutkasiga - Metoprolol suksinat 25-100 mg 1 marta sutkasiga - Nebivalol 2,5-10 mg 1 marta sutkasiga - Karvedilol 3,125-25 mg kunlik dozasi 2-3 marta sutkasiga bo‘linib beriladi						10 mg - Metoprolol suksinat 25-100 mg - Nebivalol 2,5-10 mg - Karvedilol 3,125-25 mg	muddati klinik holatiga bog‘liq
8. Mineralokortikoid reseptori antagonistlari: - Spironolakton - Eplerenon	- Spironolakton 25-50 mg 1 tabl. (kaps) 1 mahal; - Eplerenon 25-50 mg 1 tabl. 1 mahal	+	+	+	+	+	- Spironolakton 25-50 mg 1 tabl. (kaps) 1 mahal; - Eplerenon 25-50 mg 1 tabl. 1 mahal	Terapiya muddati klinik holatiga bog‘liq
9. SGLT2-ingibitorlari: - Empagliflozin - Dapagliflozin	- Empagliflozin 10-25 mg 1 tabl. 1 mahal; - Dapagliflozin 10 mg 1 tabl. 1 mahal.	+	+	+	+	+	- Empagliflozin 10-25 mg 1 tabl. 1 mahal; - Dapagliflozin 10 mg 1 tabl. 1 mahal.	Terapiya muddati klinik holatiga bog‘liq

Izoh: [1] Virusli miokarditga shubha bo‘lsa, virusga qarshi dori vositalari qo‘llanilishi mumkin.

[2] Antibiotiklarni faqat bakterial infeksiyasi tasdiqlangan taqdirda qo‘llash mumkin. Antibiotiklarga sezuvchanlik natijalariga ko‘ra, boshqa turidagi antibakterial vositalardan foydalanish mumkin.

[3] Kolxisinni miokardit yondosh perikardit bilan birga kechsa, qo‘llash tavsiya etiladi.

[4] Glyukokortikosteroidlar uchun ko‘rsatma: limfositar miokardit; gigant hujayrali miokardit; autoimmun kasalliklar bilan bog‘liq miokardit; sarkoidli miokardit; allergik miokardit.

[5] ARNI ChQ OF past (<40%) bo‘lgan miokarditli bemorlarda RAAT blokatorlariga qaraganda afzalroq.

Beta-blokatorlar, RAAT blokatorlari (AAFi yoki sartanlar), MKRA va SGLT2-ingibitorlari miokarditning nospesifik terapiyasi deb hisoblanadi va barcha bemorlarga buyurilishi mumkin.

Davolash tadbirlari (qo‘shimcha medikamentoz davo)		SHOSHILINCH tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha					O‘rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
Dori-vositaning	Dori-vositaning	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar)	Viloyat darajasidagi	Respublika darajasidagi		

(xalqaro patentlanmagan) nomi	dozirovkasi va qo‘llanilishi			shifoxonalari	tibbiyot muassasalari	tibbiyot muassasalari		
1. Oral antikoagulyantlar[1]: - Rivaroksaban - Apiksaban	- Rivaroksaban 15-20 mg 1 mahal - Apiksaban 2,5-5 mg 2 mahal		+	+	+	+	- Rivaroksaban 15-20 mg 1 mahal - Apiksaban 2,5-5 mg 2 mahal	Terapiya muddati klinik holatiga bog‘liq
2. Bevosita antikoagulyantlar: - Geparin - Enoksiparin	- Geparin 5000 TB t/o 4 mahal; - Enoksiparin 100 antiXa TB bemorni 1 kg vazniga nisbatan 2 mahal			+	+	+	- Geparin 5000 TB t/o 4 mahal; - Enoksiparin 100 antiXa TB bemorni 1 kg vazniga nisbatan 2 mahal	
3. Antiaritmiklar: - Amiodaron - Verapamil - ATF - Lidokain - Esmolol - Atropin	- Amiodaron 5%-3 ml v/i; - Verapamil 0,25%-2 ml v/i - ATF 1%-1 ml v/i - Lidokain 1%-2 ml v/i - Esmolol 1%-1 ml v/i - Atropin 0,1%-1 ml t/o, v/i		+	+	+	+	- Amiodaron 5%-3 ml v/i; - Verapamil 0,25%-2 ml v/i - ATF 1%-1 ml v/i - Lidokain 1%-2 ml v/i - Esmolol 1%-1 ml v/i - Atropin 0,1%-1 ml t/o, v/i	
4. Ivabradin	5-7,5 mg 1 tabl. 2 mahal		+	+	+	+	5-7,5 mg 1 tabl. 2 mahal	
5. Trimetazidin	80 mg 1 marta sutkasiga, 35 mg 2 marta sutkasiga	+	+	+	+	+	70-80 mg	
6. Ranolazin	500-1000 mg 2 marta sutkasiga	+	+	+	+	+	1000-2000 mg	
7. Halqa diuretiklar: - Furosemid - Torasemid	- Furosemid 1%-2 ml v/i; - Torasemid 2,5%-4 ml v/i	+	+	+	+	+	- Furosemid 1%-2 ml v/i; - Torasemid 2,5%-4 ml v/i	
8. Vazopressorlar:	- Dobutamin 2,5-10						- Dobutamin	

- Dobutamin - Dopamin - Noradrenalin	mkg/kg/daq v/i; - Dopamin 1-20 mkg/kg/daq v/i; - Noradrenalin 0,05-0,3 mkg/kg/daq v/i						2,5-10 mkg/kg/daq v/i; - Dopamin 1-20 mkg/kg/daq v/i; - Noradrenalin 0,05-0,3 mkg/kg/daq v/i	
Izoh: [1]Miokardit bilan og‘rigan bemorlarda BF borligida oral antikoagulyantlari buyuriladi.								

(OPERATIV DAVO)

Davolash tadbirlari (operativ davo) Jarrohlik amaliyoti/aralashuv/muolaja nomi	Rejali tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam		
	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
1. Vaqtinchali/Doimiy EKS o‘rnatish			+	+	+
2. IKD o‘rnatish				+	+
3. CRT uskunasini o’rnatish				+	+
4. Radiochastotali ablasiya				+	+
5. Aorta ichi ballonli kontrpul'sasiyasi				+	+
Izoh: Jarrohlik aralashuvlarga bo‘lgan ko‘rsatmalar ko‘p toifali konsilium qarori asosida aniqlanishi kerak.					

(PARHEZ)

Ovqatlanish tartibi Parhez stoli va uning davomiyligi	Тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam		
	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
1. 10-sonli stol umrbod	+	+	+	+	+

(DISPANSERIZATSIYA)

Dispanserizatsiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OShP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Dispanser nazorati muddati
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Hamshira	+	+	- o‘tkir asoratlanmagan miokarditdan keyin 1 marta - 3 oy davomida har oyda bir marta o‘tkir asoratlangan miokarditdan keyin - SYuYe I-II FS bilan surunkali miokardit uchun: yiliga 2 marta; - SYuYe III-IV FS bilan surunkali miokardit uchun yiliga 4 marta	umrbod
	2. Oilaviy shifokor				
	3. Kardiolog		+		
	4. Terapevt		+		
	5. Revmatolog		+		
	6. LOR		+		
Izoh: Yurak-qon tomir tizimining faoliyatini nazorat qilish uchun takroriy tekshiruvlar tavsiya etiladi.					
Laborator tekshiruvlar	1. Umumiy qon tahlili	+	+	- o‘tkir asoratlanmagan miokarditdan keyin 1 marta - 3 oy davomida har oyda bir marta o‘tkir asoratlangan miokarditdan keyin - SYuYe I-II FS bilan surunkali miokardit uchun: yiliga 2 marta; - SYuYe III-IV FS bilan surunkali miokardit uchun yiliga 4 marta	
	2. Umumiy siydik tahlili	+	+		
	3. CRO	+	+		
	4. Qondagi kreatinin	+	+		
	5. ASLO	+	+		
	6. ALT, AST, bilirubin	+	+		
	7. Koagulogramma	+	+		
	8. Troponin		+		
	9. RF		+		
Izoh: Davriy ko‘riklarda ko‘rsatmaga muvofiq qo‘shimcha laborator tekshiruvlar tavsiya qilinadi.					
Инструментал текширувлар	1. EKG	+	+	- o‘tkir asoratlanmagan	

				miokarditdan keyin 1 marta - 3 oy davomida har oyda bir marta o‘tkir asoratlangan miokarditdan keyin - SYuYe I-II FS bilan surunkali miokardit uchun: yiliga 2 marta; - SYuYe III-IV FS bilan surunkali miokardit uchun yiliga 4 marta III-IV FS uchun yiliga 4 marta	
	2. EXOKG		**+**	**Ko‘rsatmaga muvofiq**	
	3. XMEKG		**+**		
	4. Ko’krak qafasi rentgenografiyasi		**+**		
Izoh: Davriy ko‘riklarda ko‘rsatmaga muvofiq qo‘shimcha instrumental tekshiruvlar tavsiya qilinadi.					